

Neurodivergentes Burnout nicht nur bei ADHS

Von: **ADHSSpektrum** | newsletter@steadyhq.com

25. Juli 2026 um 08:02

An: **svenja@festerling.org**

[Im Browser lesen](#)



ADHS BLOG UND COMMUNITY ADHSSPEKTRUM

Neurodivergentes Burnout: Wenn Kompensation, Schlaf und Selbstregulation gleichzeitig kippen

Willkommen im Spektrum!

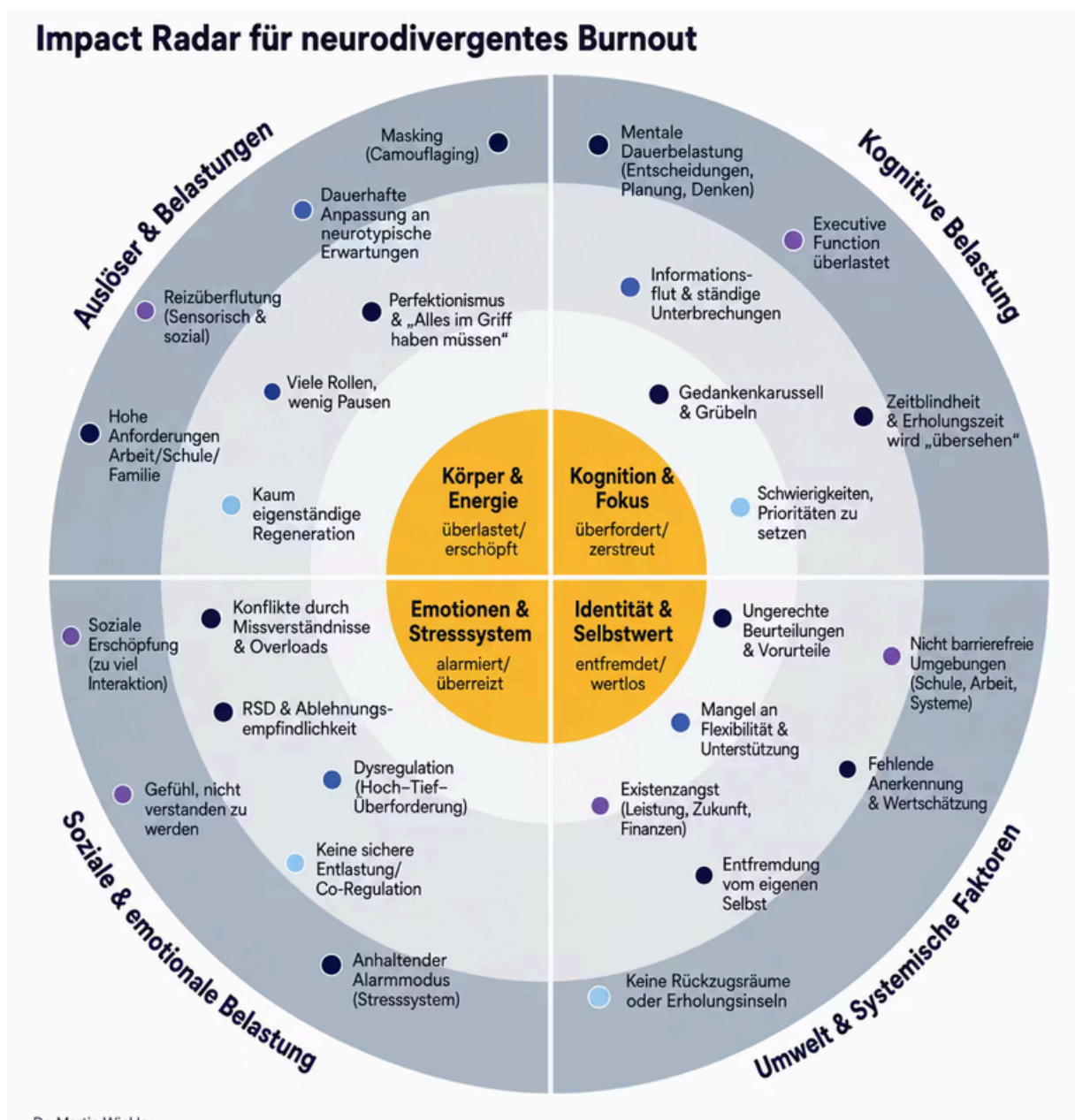
Neurodivergentes Burnout ist mehr als Müdigkeit. Es ist auch nicht einfach die neurodivergente Variante eines beruflichen Erschöpfungssyndroms.

Viele Betroffene beschreiben einen Zustand, in dem mehrere Fähigkeiten gleichzeitig wegbrechen:

- Reize lassen sich kaum noch filtern.
- Entscheidungen werden unverhältnismäßig schwer.
- Sprache, Planung und Selbstorganisation funktionieren schlechter.
- Soziale Kontakte werden anstrengend oder unerträglich.

- Emotionen schlagen schneller in Alarm, Erstarrung oder Rückzug um.
- Selbstverständliche Alltagshandlungen kosten plötzlich enorme Kraft.
- Frühere Kränkungen, Konflikte und Misserfolge wirken wieder erschreckend gegenwärtig.

Das **Impact Radar für neurodivergentes Burnout** versucht, diese Gleichzeitigkeit sichtbar zu machen. Es sucht nicht nach *dem einen Auslöser*. Es zeigt, wie Belastungen aus Körper, Kognition, Stresssystem, Identität, Beziehungen und Umwelt miteinander in Resonanz geraten.





Der entscheidende Gedanke lautet:

Neurodivergentes Burnout entsteht meist nicht, weil ein Mensch grundsätzlich zu wenig belastbar ist. Es entsteht, wenn die Summe der Anforderungen dauerhaft größer wird als die verfügbare Regulation, Regeneration und Unterstützung.

Was wissen wir 2026 tatsächlich?

Der Begriff **neurodivergentes Burnout** ist ein klinisch und lebensweltlich hilfreicher Oberbegriff, aber bislang keine einheitlich definierte Diagnose.

Die wissenschaftliche Basis ist derzeit für das **autistische Burnout** am stärksten. Eine 2025 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit wertete 48 Studien mit insgesamt etwa 4.000 autistischen Menschen aus. Beschrieben wurden vor allem eine tiefgreifende Erschöpfung, eine Zunahme von Beeinträchtigungen, sensorische und soziale Überlastung, Camouflaging beziehungsweise Masking, alltägliche Anpassungsanforderungen sowie fehlendes Verständnis und unzureichende Unterstützung. Die Verläufe konnten chronisch sein und von krisenhaften Einbrüchen unterbrochen werden. Die untersuchten Stichproben bestanden allerdings überwiegend aus weißen, weiblichen und spät diagnostizierten Erwachsenen ohne intellektuelle Beeinträchtigung. Die Ergebnisse lassen sich daher nicht ohne Weiteres auf das gesamte Autismus-Spektrum übertragen. ([King's College London](#))

Bereits die grundlegende Arbeit von Raymaker und Kolleg:innen beschrieb autistisches Burnout als Folge chronischer Lebensbelastung bei der Erwartungen und Anforderungen die

Lebensbelastung, bei der Erwartungen und Anforderungen die verfügbaren Fähigkeiten und Unterstützungsressourcen übersteigen. Als Kernmerkmale wurden anhaltende Erschöpfung, Funktionsverlust und eine deutlich verminderte Reiztoleranz benannt. Entlastend wirkten nach den Erfahrungen der Befragten unter anderem reduzierte Anforderungen, Akzeptanz, soziale Unterstützung und die Möglichkeit, weniger maskieren zu müssen. ([PubMed](#))

Für ein eigenständiges **ADHS-Burnout** ist die Forschungslage wesentlich dünner. Studien zeigen aber deutliche Zusammenhänge zwischen ADHS-Merkmalen, beruflichem Stress, psychischer Erschöpfung, exekutiver Überlastung und Schlafproblemen. Eine Untersuchung von 2024 fand Hinweise darauf, dass Einschränkungen der exekutiven Funktionen den Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomen und beruflichem Burnout mitvermitteln können. Eine Studie aus dem Jahr 2025 zeigte außerdem, dass der Zusammenhang zwischen ausgeprägteren ADHS-Merkmalen und geringerer Lebensqualität teilweise über die Schwere einer Insomnie vermittelt wurde. ([PubMed](#))

Bei **AuDHS**, also der Kombination aus Autismus und ADHS, können sich unterschiedliche Belastungsmechanismen überlagern: das Bedürfnis nach Vorhersagbarkeit trifft auf Schwierigkeiten mit Planung und Zeitsteuerung; sensorische Empfindlichkeit trifft auf eine häufig wechselnde Aufmerksamkeitsausrichtung; der Wunsch nach Rückzug trifft auf innere Unruhe oder einen hohen Stimulationsbedarf. Das ist klinisch plausibel, bislang aber noch kein ausreichend erforschtes eigenständiges Burnout-Syndrom.

Auch begrifflich ist eine Abgrenzung notwendig: Die WHO definiert Burnout in der ICD-11 ausschließlich als Folge chronischen, nicht erfolgreich bewältigten **Arbeitsstresses** und ordnet es nicht als eigenständige Erkrankung ein. Autistisches oder neurodivergentes Burnout geht dagegen oft weit über den Arbeitsplatz hinaus und betrifft Alltag, Beziehungen, Selbstversorgung, sensorische Verarbeitung und Identität. ([Weltgesundheitsorganisation](#))

Das Impact Radar ist keine Checkliste

Das Radar sollte nicht wie ein Test verstanden werden, bei dem möglichst viele Punkte angekreuzt werden müssen. Es ist eine **Landkarte dynamischer Wechselwirkungen**.

Im Zentrum stehen vier Funktionssysteme:

1. **Körper und Energie**
2. **Kognition und Fokus**
3. **Emotionen und Stresssystem**
4. **Identität und Selbstwert**

In den äußeren Bereichen befinden sich Belastungen und Bedingungen, die diese Systeme beanspruchen:

- allgemeine Anforderungen und Masking,
- kognitive Dauerbelastung,
- soziale und emotionale Belastungen,
- Umwelt- und Systemfaktoren.

Die farbigen Punkte markieren unterschiedliche Funktionen:

- **Haupttreiber** halten das Burnout-System aktiv.
-

- **Verstärker** erhöhen die Wirkung bereits vorhandener Belastungen.
- **fehlende Schutzfaktoren** verhindern Erholung.
- **Frühwarnsignale** zeigen, dass das System seine Kompensationsreserven verliert.

Wichtig ist dabei: Derselbe Faktor kann je nach Person eine andere Rolle haben. Ein Großraumbüro kann bei einem Menschen der Haupttreiber sein, bei einem anderen nur ein Verstärker. Eine Auseinandersetzung mit der Vorgesetzten kann ein aktueller Konflikt sein – oder ein Auslöser für ein wesentlich älteres Beschämungs- und Bedrohungsnetzwerk.





1. Körper und Energie: Erschöpfung ist nicht nur Energiemangel

Im klassischen Erschöpfungsmodell erscheint der Körper wie ein Akku: Belastung verbraucht Energie, Erholung lädt ihn wieder auf.

Bei neurodivergentem Burnout reicht dieses Modell nicht aus.

Viele Betroffene ruhen sich aus und fühlen sich trotzdem nicht erholt. Sie schlafen länger, wachen aber wie „überfahren“ auf. Bereits das Aufstehen, Duschen oder Anziehen kann überfordernd werden. Gleichzeitig kann das Nervensystem trotz körperlicher Erschöpfung hochaktiv bleiben.

Das Problem ist dann nicht nur ein leerer Akku. Es ist ein System, das auch in Ruhe weiterhin Energie verbraucht:

- Geräusche werden fortlaufend registriert.
- mögliche Anforderungen werden innerlich vorweggenommen,
- soziale Begegnungen werden nachanalysiert,
- unerledigte Aufgaben bleiben als Alarmmeldungen aktiv,
- frühere Konflikte werden erneut abgespielt,
- der Körper bleibt in Erwartung der nächsten Störung.

Sensorische Verarbeitung ist dabei kein Nebenthema. Auch außerhalb einer formalen Autismus- oder ADHS-Diagnose waren höhere sensorische Empfindlichkeit und Schwierigkeiten der Reizregistrierung in einer Studie mit stärkerem subjektivem Stress und mehr Burnout-Symptomen verbunden. ([PubMed](#))

Die Erschöpfung ist daher häufig eine Mischung aus:

zu wenig verfügbarer Energie, zu hohem Grundverbrauch und zu geringer nächtlicher Wiederherstellung.

2. Kognition und Fokus: Wenn jede Kleinigkeit zu einer Steuerungsaufgabe wird

Menschen ohne ausgeprägte exekutive Schwierigkeiten erledigen viele Alltagsschritte weitgehend automatisch.

Bei ADHS, Autismus oder AuDHS können dieselben Abläufe eine bewusste Steuerung erfordern:

- Was muss ich zuerst tun?
- Wann muss ich anfangen?
- Wie lange wird es dauern?
- Was brauche ich dafür?
- Was mache ich mit der Unterbrechung?
- Wie finde ich anschließend wieder in die Aufgabe zurück?

- Wie habe ich anschließend wieder in die Aufgabe zurück?
- Welche von fünf gleichzeitig dringenden Dingen ist wirklich wichtig?

Solange genügend Energie vorhanden ist, kann dies durch Intelligenz, Erfahrung, Perfektionismus, Routinen und erheblichen inneren Druck kompensiert werden.

Im Burnout bricht nicht unbedingt das Wissen weg. Es fehlt der **funktionale Zugriff** darauf.

Die Person weiß weiterhin, wie man eine Rechnung überweist. Aber die Handlungskette aus Brief öffnen, Daten erfassen, Banking-App starten, TAN bestätigen und den Vorgang abschließen fühlt sich plötzlich unüberwindbar an.

Das ist ein zentraler Unterschied zwischen Fähigkeit und Verfügbarkeit:

Eine Fähigkeit kann grundsätzlich vorhanden sein und unter Überlastung dennoch vorübergehend nicht abrufbar werden.

Unterbrechungen, Kontextwechsel und unklare Zuständigkeiten erhöhen diese Belastung zusätzlich. Das Gehirn muss nach jeder Störung seine innere Landkarte neu aufbauen: Wo war ich? Was war das Ziel? Welche Regel gilt jetzt? Was ist bereits erledigt?

Bei einem erschöpften Regulationssystem wird aus jeder Unterbrechung eine kleine **Orientierungerschütterung**.

3. Emotionen und Stresssystem: Das Burnout als Alarmzustand

Neurodivergentes Burnout kann äußerlich wie ein Energiemangel wirken und innerlich dennoch ein Zustand permanenter Alarmierung sein.

Typische Auslöser sind:

- Kritik und Beschämung,
- soziale Mehrdeutigkeit,
- nicht beantwortete Nachrichten,
- unklare Erwartungen,
- Konflikte und Missverständnisse,
- plötzlich veränderte Pläne,
- das Gefühl, andere enttäuscht zu haben,
- die Angst, erneut zu versagen.

Bei ADHS wird in diesem Zusammenhang häufig von Ablehnungs- oder Zurückweisungsempfindlichkeit gesprochen. „RSD“ ist keine eigenständige offizielle Diagnose, beschreibt aber für viele Betroffene verständlich, wie stark tatsächliche oder erwartete Ablehnung den gesamten Funktionszustand verändern kann.

Die emotionale Reaktion bleibt dann nicht auf das Gefühl beschränkt. Sie beeinflusst:

- Aufmerksamkeit,
- Arbeitsgedächtnis,
- Impulskontrolle,

- Sprachzugriff,
- Körperanspannung,
- Schlaf und
- die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen.

Aus einem unangenehmen Gespräch kann so ein mehrtägiger Funktionsabfall entstehen.

Gerade bei einer zusätzlichen Traumafolgestörung kann eine aktuelle Belastung ältere Netzwerke aktivieren. Der Mensch reagiert dann nicht nur auf das heutige Ereignis, sondern auf ein ganzes Paket früherer Erfahrungen von Ausgrenzung, Überforderung oder Beschämung. ADHS und posttraumatische Belastungsstörungen treten zudem nicht selten gemeinsam auf; eine systematische Übersicht von 2025 beschrieb bei dieser Kombination stärkere psychosoziale Beeinträchtigungen und ausgeprägtere funktionelle Schwierigkeiten. ([PubMed](#))

4. Identität und Selbstwert: Wenn die Kompensation mit dem Selbst verwechselt wurde

Viele spät diagnostizierte Menschen haben ihre neurodivergenten Besonderheiten jahrzehntelang nicht als Unterschiede der Reizverarbeitung und Selbststeuerung verstanden.

Sie entwickelten stattdessen biografische Erklärungen wie:

- Ich bin faul.

- Ich bin undiszipliniert.
- Ich bin zu empfindlich.
- Ich bin egoistisch.
- Mit mir stimmt etwas nicht.
- Andere schaffen das doch auch.

Häufig wurde das Selbstwertgefühl an eine einzige Bedingung geknüpft:

Solange ich funktioniere, bin ich in Ordnung.

Bricht die Kompensation zusammen, entsteht deshalb nicht nur Angst vor konkreten Folgen. Es kommt zu einer Identitätskrise.

Eine aktuelle qualitative Untersuchung beschreibt autistisches Burnout ausdrücklich nicht nur als Erschöpfung, sondern auch als funktionellen Zusammenbruch, Scham und Störung des bisherigen Identitätserlebens. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2026 untersuchte, wie autistische Erwachsene das „Herunterfahren“ ihrer Fähigkeiten und die zunehmende Notwendigkeit von Rückzug erleben – bei früh diagnostizierten Menschen zum Teil anders als bei spät diagnostizierten Erwachsenen, die ihre eigenen Bedürfnisse lange nicht einordnen konnten. ([PubMed](#))

Gerade Hochleistende sind gefährdet, weil ihr Umfeld die Überlastung spät erkennt. Von außen sieht man Kompetenz. Unsichtbar bleiben die Kosten:

- ständige Selbstüberwachung,
- übermäßige Vorbereitung,

- nächtliches Nacharbeiten,
- soziale Skripte,
- Perfektionismus,
- Panik vor Fehlern,
- vollständiger Rückzug nach außen erfolgreichem Funktionieren.

Das Burnout beginnt häufig lange vor dem sichtbaren Zusammenbruch.

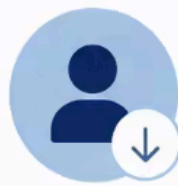
Frühwarnsignale – achte auf dich!

Neurodivergentes Burnout kündigt sich oft früh an –
je eher du es bemerkst, desto besser lässt sich gegensteuern.



1. Steigende Reizempfindlichkeit

Geräusche, Licht und Gerüche werden schneller zu viel.



2. Rückzug & Interessenverlust

Soziale Kontakte und Hobbys werden anstrengend.



3. Erholungszeit wird länger

Ausruhen hilft kaum noch, Erschöpfung bleibt.



4. Emotionaler Overload

Schneller gereizt, überfordert, tränennah oder erstarrt.



5. Kognitive Stolperer nehmen zu

Vergesslichkeit, Wortfindung und Planungschaos häufen sich.



6. Selbstwert im Sinkflug

Mehr Selbstkritik, Scham und Gefühl von Versagen.



7. Schlaf kippt

Ein- oder Durchschlafen, Alpträume oder Grübeln nehmen zu.



8. Masking kostet immer mehr Kraft

Funktionieren wirkt nach außen möglich, innen wird es teurer.



Merksatz

Wenn mehrere Frühwarnsignale gleichzeitig zunehmen, ist das kein persönliches Versagen – sondern ein Hinweis





Masking: Funktionieren auf Kosten der Regeneration

Masking oder Camouflaging bedeutet mehr als das Verbergen einzelner autistischer Merkmale.

Es kann beinhalten:

- Blickkontakt bewusst herzustellen,
- spontane Bewegungen oder Stimming zu unterdrücken,
- Gesprächsverläufe vor auszuplanen,
- Mimik und Tonfall anderer zu analysieren,
- eigene Überforderung nicht zu zeigen,
- Pausenbedürfnisse zu überspielen,
- soziale Regeln kognitiv statt intuitiv zu bearbeiten,
- auch den bereits eingetretenen Funktionsverlust zu verbergen.

Masking kann kurzfristig vor Ausgrenzung schützen, berufliche Teilhabe ermöglichen oder soziale Sicherheit erhöhen. Es ist daher nicht grundsätzlich eine „falsche“ Strategie.

Problematisch wird es, wenn Masking unfreiwillig, dauerhaft und ohne sichere Erholungsräume erfolgt. Eine systematische Übersicht zeigt, dass stärkeres selbsttherapeutisches

Übersichtsarbeit zeigte, dass stärkeres selbstberichtetes Camouflaging insgesamt mit ungünstigeren psychischen Gesundheitswerten verbunden war. Die aktuelle Burnout-Forschung bewertet Masking zudem als wichtigen möglichen Belastungsfaktor, auch wenn die Richtung der Zusammenhänge und individuelle Unterschiede weiter untersucht werden müssen. ([PubMed](#))

Unmasking ist deshalb ebenfalls nicht pauschal die Lösung. Ein Mensch kann nur dort sicher weniger maskieren, wo Unterschiede nicht unmittelbar bestraft, abgewertet oder gegen ihn verwendet werden.

Die Rolle des Schlafs: Die Nachtschicht des Gehirns

Schlaf ist keine passive Pause. Während des Schlafs werden Informationen sortiert, Gedächtnisinhalte stabilisiert, emotionale Erfahrungen neu gewichtet und mit bereits vorhandenem Wissen verbunden.

Dabei wirken verschiedene Schlafstadien zusammen. REM-Schlaf spielt eine wichtige Rolle bei emotionalem Gedächtnis, ist aber nicht allein für emotionale Verarbeitung zuständig. Auch Non-REM-Schlaf, Tiefschlaf, Schlafspindeln und die zeitliche Abfolge der Schlafstadien tragen zur Konsolidierung und Neuorganisation von Gedächtnisinhalten bei. ([PMC](#))

Menschen mit ADHS und Autismus berichten überdurchschnittlich häufig über:

- Einschlafprobleme,

- verzögerte Schlafphasen,
- instabile Schlafzeiten,
- häufiges Erwachen,
- nicht erholsamen Schlaf,
- Tagesmüdigkeit,
- eine Diskrepanz zwischen subjektiver und objektiver Schlafqualität.

Systematische Übersichten bestätigen relevante Schlaf- und zirkadiane Probleme sowohl bei erwachsenen autistischen Menschen als auch bei Erwachsenen mit ADHS. Die konkreten Veränderungen der Schlafarchitektur sind jedoch uneinheitlich und nicht bei jeder Person gleich. ([PubMed](#))

Im Impact Radar gehört Schlaf deshalb nicht nur in den Bereich **Körper und Energie**. Er beeinflusst gleichzeitig alle vier Zentren:

- Energie und Reizschwelle,
- Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis,
- Emotionsregulation und Alarmbereitschaft,
- Selbstbewertung und Hoffnung.

Schlaf & REM – warum es so entscheidend ist

Schlaf ist die Nachtschicht des Gehirns: Er ordnet Informationen, reguliert Emotionen und beeinflusst unsere Reiz- und Stressverarbeitung am nächsten Tag.

GESUNDER SCHLAF

GESTÖRTER SCHLAF



Was meine ich mit „REM-Fragmenten“?

Der Begriff **REM-Fragment** ist kein etablierter schlafmedizinischer oder neurobiologischer Fachbegriff. Er bezeichnet weder einen standardisierten EEG-Befund noch nachweisbare kleine Stücke von REM-Schlaf.

Ich verwende ihn als **klinisches Arbeitsmodell**.

Gemeint sind emotional, sensorisch und körperlich hoch aufgeladene Erinnerungselemente, die nicht ausreichend in einen beruhigten autobiografischen Zusammenhang eingeordnet wurden.

Sie können sich zeigen als:

- plötzlich auftauchendes inneres Bild,
- kurzer Film oder eine bestimmte Szene,
- Körpergefühl ohne klare Geschichte,
- Druck, Enge, Hitze oder Erstarrung,
- ein Satz wie „Ich bin schuld“,
- ein starkes Gefühl von Ausgeschlossen- oder Ausgeliefertsein,
- ein Handlungsimpuls zu Flucht, Angriff, Rechtfertigung oder Rückzug,
- eine aktuelle Situation, die sich älter und größer anfühlt, als sie objektiv ist.

Der Ausdruck versucht zu beschreiben, dass die Erfahrung zwar erinnerungsartig gespeichert ist, aber nicht wie eine abgeschlossene Vergangenheit erlebt wird.

Das Ereignis wird nicht nur erinnert. Der dazugehörige Zustand wird erneut hergestellt.

Die wissenschaftliche Brücke zum REM-Schlaf

Für das Modell gibt es eine plausible wissenschaftliche Anschlussstelle, aber keinen direkten Beweis.

Eine systematische Übersichtsarbeit von 2025 untersuchte REM-

Schlaf, dysphorische Traume und Alpträume bei psychischen Erkrankungen mit Emotionsdysregulation. Die Autor:innen beschreiben fragmentierten REM-Schlaf als möglichen Störfaktor bei der nächtlichen Auflösung emotionaler Belastung. In die Auswertung gingen 28 Studien ein, überwiegend zu posttraumatischen Belastungsstörungen, affektiven Störungen und Angststörungen. Nur eine Studie bezog sich auf Autismus. Daraus lässt sich also kein spezifischer REM-Mechanismus des neurodivergenten Burnouts ableiten. ([PubMed](#))

Die Forschung unterstützt folgende vorsichtige Aussage:

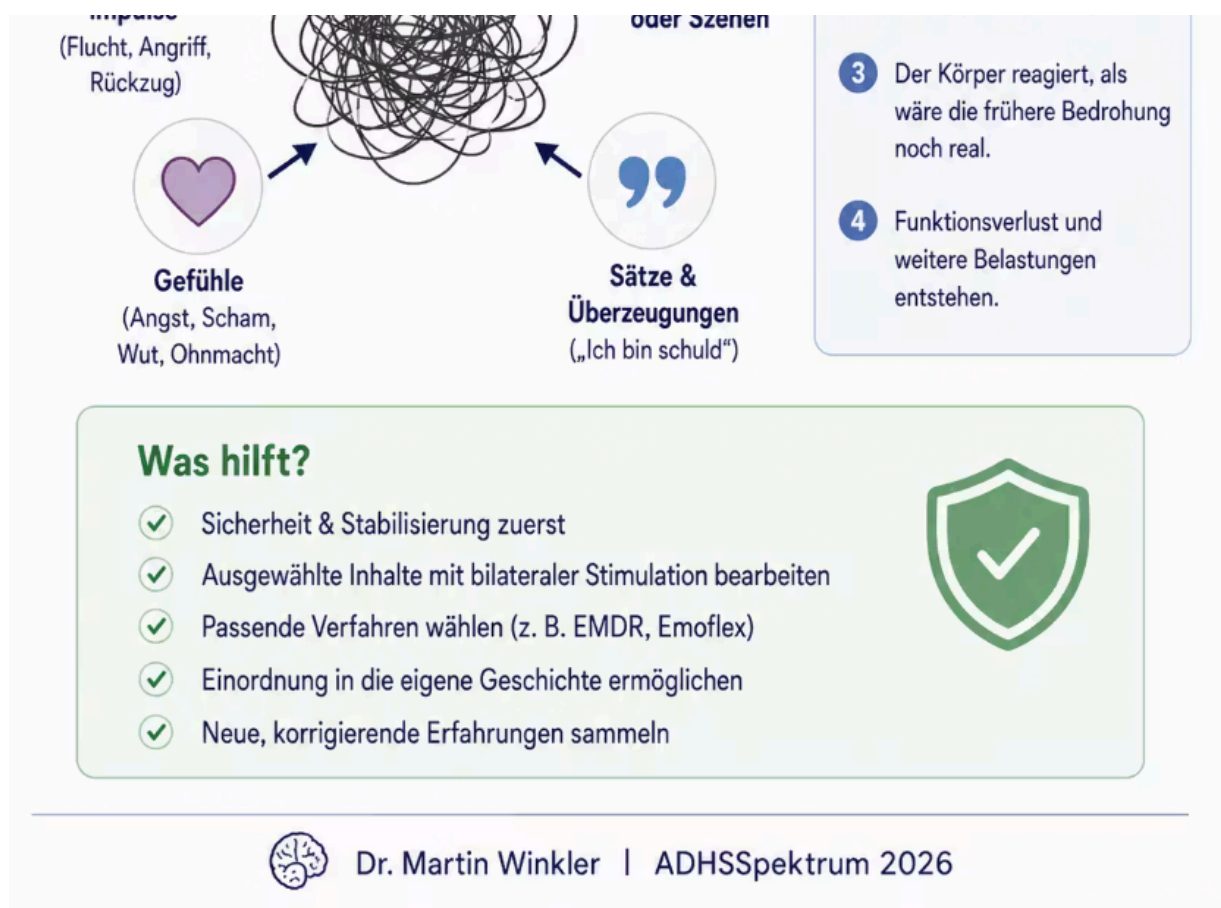
Kontinuierlicher, ausreichend erholsamer Schlaf kann die Verarbeitung emotionaler Erfahrungen unterstützen. Fragmentierter Schlaf, Alpträume und wiederholte nächtliche Aktivierung können diese Verarbeitung beeinträchtigen und die Emotionsregulation am Folgetag verschlechtern.

Nicht belegt ist dagegen die stärkere Behauptung:

Neurodivergentes Burnout werde durch nachweisbare „REM-Fragmente“ verursacht.

Der Begriff bleibt deshalb eine **therapeutische Metapher und Modellvorstellung**, keine diagnostische Feststellung.





Wie REM-Fragmente ein Burnout-System verstärken könnten

Als Arbeitsmodell lässt sich ein Kreislauf beschreiben.

1. Tagsüber entsteht mehr emotional markiertes Material

Ein neurodivergenter Mensch muss möglicherweise an einem einzigen Tag Dutzende kleine Anpassungsleistungen erbringen:

- eine Planänderung kompensieren,
- ein Geräusch aushalten,

- eine soziale Mehrdeutigkeit interpretieren,
- einen Fehler verbergen,
- eine begonnene Aufgabe nach Unterbrechung rekonstruieren,
- eine kritische Reaktion innerlich abfangen,
- Überforderung maskieren.

Jedes Ereignis mag einzeln gering erscheinen. In der Summe entsteht eine hohe Dichte emotional markierter Informationen.

2. Die nächtliche Verarbeitung wird instabil

Stress, Grübeln, unregelmäßige Schlafzeiten, sensorische Störungen, Albträume oder körperliche Anspannung beeinträchtigen die Schlafkontinuität.

Das Gehirn bekommt mehr Material – aber weniger störungsfreie Zeit, es zu sortieren.

3. Alte und neue Erfahrungen verbinden sich über Alarmähnlichkeit

Eine heutige unbeantwortete E-Mail kann sich mit früheren Erfahrungen verbinden:

- zu spät gewesen zu sein,
- beschämt worden zu sein,
- jemanden enttäuscht zu haben,
- unzuverlässig zu wirken,
- aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden.

Die aktuelle Nachricht ist dann nur noch der Auslöser. Die Intensität stammt aus einem viel größeren Netzwerk.

4. Das erschöpfte Gehirn verliert Kontext

Unter hoher Belastung fällt es schwerer, sich innerlich zu sagen:

- Das war damals.
- Diese Person ist nicht meine frühere Lehrerin.
- Eine verspätete Antwort ist unangenehm, aber keine Katastrophe.
- Ich darf um Klärung bitten.
- Ich muss nicht alles sofort lösen.

Der alarmierte Zustand wird dadurch schneller zur scheinbaren Realität.

5. Der Funktionsverlust erzeugt neues Material

Die Person vermeidet die E-Mail, verpasst eine Frist oder zieht sich zurück. Daraus entstehen neue Konflikte und neue Scham.

Das Burnout-System produziert damit fortlaufend genau jene Erfahrungen, die es anschließend weiter aktivieren.

Der Unterschied zwischen Erschöpfung und Alarm-Erschöpfung

Das Impact Radar hilft, zwei Zustände auseinanderzuhalten.

Reine Erschöpfung

Die Person ist müde, kann aber grundsätzlich abschalten. Ruhe, Schlaf und reduzierte Anforderungen führen schrittweise zu einer spürbaren Erholung.

Alarm-Erschöpfung

Die Person ist vollkommen erschöpft, kann aber innerlich nicht aufhören zu scannen, zu grübeln, zu kontrollieren oder sich vorzubereiten. Ruhe wird mit Schuldgefühl, innerer Unruhe oder drohenden Gedanken gefüllt.

In der Alarm-Erschöpfung ist „mehr schlafen“ zwar wichtig, reicht aber häufig nicht. Auch die Zahl der inneren und äußeren Alarmquellen muss sinken.

Dazu können gehören:

- reale Anforderungen,
- sensorische Belastungen,
- ungelöste Konflikte,
- unklare Zuständigkeiten,
- unerledigte Aufgaben,
- Beschämungsnetzwerke,
- traumatisch aufgeladene Erinnerungen,

- fehlende Rückzugsmöglichkeiten,
- ein weiterhin notwendiges Vollzeit-Masking.

Bilaterale Stimulation, EMDR und Emoflex

Bilaterale Stimulation wird vor allem aus der EMDR-Therapie bekannt. Dabei richtet die Person ihre Aufmerksamkeit auf einen belastenden Gedächtnisinhalt und erhält gleichzeitig alternierende visuelle, taktile oder akustische Reize.

EMDR ist für die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen wissenschaftlich untersucht. Über den genauen Wirkmechanismus wird weiterhin diskutiert. Eine der empirisch am besten gestützten Erklärungen ist die **Arbeitsgedächtnishypothese**: Das gleichzeitige Erinnern und Ausführen einer zweiten Aufgabe beansprucht begrenzte Arbeitsgedächtnisressourcen. Dadurch können Lebhaftigkeit und emotionale Intensität einer Erinnerung abnehmen. Die Vorstellung, EMDR bilde einfach den REM-Schlaf nach, ist dagegen nicht nachgewiesen und sollte eher als historische oder anschauliche Metapher verstanden werden. ([PMC](#))

Bei **Emoflex** wird ein belastender Zustand zunächst in erfassbare innere Merkmale übersetzt:

- Wo befindet sich das Gefühl?
- Hat es eine Form, Farbe oder Oberfläche?
- Ist es nah oder fern?
- Bewegt es sich?

- Gibt es ein Bild, einen Film oder einen Satz?
- Wie reagiert der Körper darauf?

Diese Übersetzung kann helfen, aus einem diffusen Gesamtalarm einen begrenzteren, beobachtbaren Inhalt zu machen. Die bilaterale Stimulation wird dann nicht dazu eingesetzt, eine Person in eine traumatische Szene hineinzudrängen, sondern um die starre emotionale Kopplung möglicherweise beweglicher werden zu lassen.

Wissenschaftlich muss dabei sauber getrennt werden:

- Für EMDR bei PTBS besteht eine relevante Evidenzbasis.
- Für bilaterale Stimulation als Bestandteil des EMDR-Prozesses bestehen plausible und teilweise empirisch gestützte Wirkmodelle.
- Für Emoflex als eigenständiges Verfahren bei neurodivergentem Burnout liegt bislang keine vergleichbare spezifische Wirksamkeitsforschung vor.
- „REM-Fragmente“ bleiben ein klinisches Erklärungsmodell, keine bewiesene biologische Entität.

Diese Transparenz schwächt das Modell nicht. Sie macht deutlich, an welcher Stelle Forschung endet und klinische Hypothesenbildung beginnt.

Verarbeitung darf nicht zur nächsten Leistungsanforderung werden

Ein wichtiger Fehler wäre, bei ausgeprägtem Burnout sofort möglichst viele belastende Erinnerungen „abarbeiten“ zu wollen.

Ein bereits überlastetes System braucht zunächst:

- Sicherheit,
- Schlaf,
- Reizreduktion,
- Orientierung,
- medizinische Abklärung,
- weniger Anforderungen,
- verlässliche Unterstützung.

Traumaverarbeitung benötigt ausreichend Stabilität. Bei schwerer Erschöpfung, akuter Suizidalität, starker Dissoziation, psychotischen Symptomen oder fehlender äußerer Sicherheit gehört sie in einen professionell begleiteten Rahmen.

Die sinnvolle Reihenfolge lautet häufig:

Erst den Zufluss reduzieren, dann das System stabilisieren und erst anschließend ausgewählte Alarmnetzwerke bearbeiten.

Man kann keinen überlaufenden Keller trockenlegen, während oben weiterhin alle Wasserhähne geöffnet sind.

Die vier Rückkopplungsschleifen des Impact Radars

Die sensorische Schleife

Reizüberflutung führt zu Erschöpfung. Erschöpfung senkt die Reizschwelle. Dadurch werden dieselben Geräusche, Berührungen oder sozialen Situationen noch belastender.

Die exekutive Schleife

Überlastung führt zu Fehlern und Aufschub. Daraus entstehen mehr offene Aufgaben. Die offenen Aufgaben erhöhen den inneren Alarm und erschweren den Start zusätzlich.

Die soziale Schleife

Überforderung führt zu Rückzug, knapper Kommunikation oder Gereiztheit. Das Umfeld reagiert mit Unverständnis oder Kritik. Dies verstärkt Scham und Masking und erschwert es, frühzeitig Hilfe zu erbitten.

Die Identitätsschleife

Funktionsverlust wird als persönliches Versagen interpretiert. Scham verbraucht weitere Energie. Die Person versucht noch härter zu kompensieren und verschärft dadurch die Erschöpfung.

REM-Fragmente können in diesem Modell wie **alte Verstärker** wirken. Sie sorgen dafür, dass aktuelle Belastungen nicht isoliert verarbeitet werden, sondern sofort mit älteren Alarm- und Beschämungserfahrungen resonieren.

Was hilft wirklich?

Aus dem Impact Radar folgt, dass eine einzelne Intervention selten genügt.



Anforderungen reduzieren

Nicht nur Termine absagen, sondern prüfen:

- Welche Erwartungen sind tatsächlich notwendig?
- Welche Aufgaben können entfallen?
- Was kann delegiert werden?
- Welche Entscheidungen lassen sich automatisieren?
- Wo kann die Person vorübergehend mit deutlich weniger Leistung weiterbestehen?

Sensorische Barrieren abbauen

Zum Beispiel:

- Kopfhörer oder Gehörschutz,
- gedämpftes Licht,
- Rückzugsräume,
- weniger parallele Gespräche,
- Homeoffice,
- reizärmere Einkaufs- und Arbeitszeiten,
- bequemere Kleidung,
- planbare Pausen.

Exekutive Funktionen auslagern

Nicht das Gehirn soll sich noch besser organisieren. Die Umwelt soll weniger Organisation verlangen.

Hilfreich sind:

- sichtbare nächste Schritte,
- feste Ablageorte,
- Checklisten,
- externe Zeitgeber,
- Buddy-Systeme,
- schriftliche Absprachen,
- weniger Kommunikationskanäle,
- eindeutige Zuständigkeiten.

Schlaf gezielt behandeln

Schlafprobleme sollten nicht als unvermeidbarer Teil von ADHS oder Autismus abgetan werden. Dazu gehören je nach Situation:

- Abklärung einer Insomnie,
- Schlafapnoe,
- Restless-Legs-Syndrom,
- zirkadianer Verschiebung,
- Alpträumen,
- Medikamentenwirkungen,
- Substanzkonsum und
- körperlichen Ursachen.

Eine aktuelle erste randomisierte Untersuchung bei Erwachsenen mit ADHS und Schlafstörung spricht dafür, dass gezielte Schlafbehandlung nicht nur den Schlaf, sondern möglicherweise auch Müdigkeit, depressive Beschwerden und ADHS-bezogene Beeinträchtigungen günstig beeinflussen kann. Die Befunde sind vorläufig, unterstreichen aber die klinische Bedeutung des Schlafs. ([PubMed](#))

Scham reduzieren

Die Frage lautet nicht:

Warum schaffst du das nicht mehr?

Sondern:

Unter welchen Bedingungen war diese Leistung bisher überhaupt möglich – und welchen Preis hast du dafür bezahlt?

Alarmnetzwerke bearbeiten

Wenn aktuelle Situationen regelmäßig ältere, stark aufgeladene Zustände aktivieren, können traumatherapeutische, körperorientierte oder imagerybasierte Verfahren sinnvoll sein. Entscheidend ist, dass sie neurodivergenzsensibel angepasst werden und weder Reizüberlastung noch Beschämung verstärken.

Die Umwelt verändern

Die Forschung zu autistischem Burnout zeigt wiederholt, dass fehlende Anpassungen, Stigma und unpassende Erwartungen keine Randfaktoren sind. Sie gehören zum Entstehungsmodell. Erholung kann daher nicht vollständig an die betroffene Person delegiert werden. ([PubMed](#))

Das Radar in der praktischen Anwendung

Das Impact Radar kann regelmäßig mit fünf Fragen genutzt werden:

1. Wo kommt momentan die meiste Belastung hinein?

Aus Anforderungen, Kognition, Beziehungen oder Umwelt?

2. Was verstärkt die Belastung?

Schlafmangel, Masking, offene Aufgaben, Konflikte, Schmerzen oder fehlende Medikation?

3. Welcher Schutzfaktor fehlt?

Rückzug, Vorhersagbarkeit, Co-Regulation, Anerkennung, Hilfe bei Planung oder eine klare Grenze?

4. Welches Frühwarnsignal ist neu?

Mehr Reizempfindlichkeit, Sprachprobleme, sozialer Rückzug, Fehler, Alpträume, Verlust von Interessen oder zunehmende Selbstabwertung?

5. Was gehört zur Gegenwart – und was fühlt sich nach einem älteren Alarm an?

Diese letzte Frage öffnet den Zugang zum Konzept der REM-Fragmente. Sie hilft zu unterscheiden, ob ein aktuelles Problem gelöst werden muss oder ob zusätzlich ein älteres emotionales

geröst werden muss oder ob zusätzlich ein anderes emotionales Netzwerk angesprungen ist.

Burnout ist nicht automatisch Depression

Autistisches oder neurodivergentes Burnout und Depression können sich ähneln und gleichzeitig auftreten.

Bei beiden können Erschöpfung, Rückzug, Schlafprobleme, kognitive Einschränkungen und Hoffnungslosigkeit vorkommen. Beim autistischen Burnout stehen häufig zusätzlich ausgeprägte Reizintoleranz, ein Verlust zuvor verfügbarer Alltagsfähigkeiten und der starke Zusammenhang mit Masking sowie unpassenden Anforderungen im Vordergrund. Die Abgrenzung ist dennoch nicht zuverlässig über ein einzelnes Merkmal möglich. Neuere Messinstrumente für autistisches Burnout zeigen zwar vielversprechende psychometrische Eigenschaften, überschneiden sich aber weiterhin deutlich mit Depression, Angst und allgemeinem Burnout. ([PubMed](#))

Daneben müssen je nach Symptomatik weitere Ursachen geprüft werden, beispielsweise:

- körperliche Erkrankungen,
- Medikamentennebenwirkungen,
- Schlafstörungen,
- Traumafolgestörungen,
- Angststörungen,
- depressive Episoden,

- Substanzkonsum,
- hormonelle und metabolische Faktoren,
- bei ausgeprägter Belastungsintoleranz auch Erkrankungen mit postexertioneller Symptomverschlechterung.

Das Impact Radar ersetzt daher keine Diagnostik. Es ergänzt sie um eine systemische Perspektive.

Fazit: Nicht der Mensch ist zusammengebrochen – die Kompensation ist es

Neurodivergentes Burnout lässt sich am besten als **Zusammenbruch eines überbeanspruchten Kompensationssystems** verstehen.

Im Zentrum stehen nicht nur Müdigkeit und Leistungsabfall, sondern vier miteinander verbundene Bereiche:

- Körper und Energie,
- Kognition und Fokus,
- Emotionen und Stresssystem,
- Identität und Selbstwert.

Das Impact Radar macht sichtbar, wie Masking, sensorische Belastung, exekutive Anforderungen, soziale Unsicherheit, fehlende Unterstützung und ungeeignete Umwelten diese Bereiche gleichzeitig beanspruchen.

Das Konzept der **REM-Fragmente** ergänzt diese Landkarte um eine zeitliche Dimension. Es beschreibt als klinisches Arbeitsmodell, wie ältere, nicht ausreichend beruhigte emotionale und körperliche Erinnerungszustände in aktuellen Belastungssituationen wieder aktiviert werden können. Die Verbindung zu REM-Schlaf, emotionaler Gedächtnisverarbeitung und fragmentiertem Schlaf ist wissenschaftlich plausibel, aber für neurodivergentes Burnout bislang nicht direkt belegt.

Gerade deshalb ist die Formulierung wichtig:

REM-Fragmente sind keine nachgewiesene Ursache des Burnouts. Sie können ein hilfreiches Modell dafür sein, warum manche aktuellen Belastungen unverhältnismäßig viel Alarm, Energieverbrauch und Funktionsverlust auslösen.

Das Ziel darf nicht darin bestehen, neurodivergente Menschen erneut fit für dieselben überfordernden Bedingungen zu machen.

Es geht darum,

- den Zufluss an Belastungen zu reduzieren,
- Schutz und Regeneration wiederherzustellen,
- die Umwelt anzupassen,
- Scham durch Verständnis zu ersetzen,
- und dort, wo ältere Alarmnetzwerke das System blockieren, eine behutsame Verarbeitung zu ermöglichen.

In welchem Quadranten deines persönlichen Impact Radars entsteht derzeit der größte Energieverlust – und welcher Schutzfaktor fehlt dort?

NEWSLETTER ABONNIEREN

Im September werden Johannes Drischel und ich den nächsten Grundkurs zu Emflex und die Rolle von Mikro-Arousal bzw. REM-Integration anbieten. Interessenten können sich unter winkler.org@gmail.com vormerken lassen

[steadyhq.com/de/adhsspek...](https://steadyhq.com/de/adhsspektrum)

ADHS BLOG UND COMMUNITY ADHSSPEKTRUM

Du möchtest diese Art von E-Mail in Zukunft nicht mehr erhalten?

[E-Mails abbestellen](#)

ADHS Blog ADHSSpektrum Dr Martin Winkler, Kastanienallee 9, 29571 Rosche, Deutschland
Zum weiteren Impressum und Datenschutzerklärungen <https://adhsspektrum.com/impressum/>

 Made with Steady